

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO DE DECLARACIONES SOBRE AUTOLESIONES (ISAS)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Integral de Autolesiones No Suicidas (AINS / NSSI)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario de Declaraciones sobre Autolesiones (ISAS).
Nombre Original (Inglés)	<i>Inventory of Statements About Self-injury (ISAS)</i>
Autores Originales	E. David Klonsky y Catherine R. Glenn (2009), Stony Brook University.
Adaptaciones Españolas	Pérez, García-Alandete, Cañabate y Marco (2020, UV); García-Nieto et al. (2013).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación fenomenológica y funcional de autolesiones no suicidas.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de dos secciones: Sección I (13 conductas + 7 ítems descriptivos); Sección II (39 ítems funcionales).
Población y Rango	Adolescentes y adultos (>= 13 años). Poblaciones clínicas psiquiátricas, escolares y universitarias.
Tiempo de Administración	10 a 15 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto bajo licencia Creative Commons (CC0 1.0 Dominio Público). Uso libre profesional e investigador.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO FUNCIONAL DE LA AUTOLESIÓN

El ISAS fue diseñado por Klonsky y Glenn (2009) para superar las limitaciones de los inventarios que se limitaban a registrar la mera frecuencia física de las autolesiones, incorporando una comprensión analítico-funcional de la **Conducta Autolesiva No Suicida (AINS)** según los criterios del DSM-5.

El modelo teórico del ISAS asume que la autolesión no es un síntoma aleatorio ni una búsqueda de llamar la atención en el sentido vulgar, sino una conducta desadaptativa aprendida que cumple **funciones de regulación intrapersonal** (especialmente la modulación del dolor afectivo insoportable, la terminación de estados disociativos y el autocastigo) y **funciones interpersonales** (comunicación de angustia extrema, demanda de auxilio o establecimiento de límites vinculares). Conocer las funciones activas en cada paciente es el prerequisite imprescindible para seleccionar las técnicas terapéuticas adecuadas (Terapia Dialéctico-Conductual, DBT).

3. ESTRUCTURA DE SECCIONES Y SUPERFACTORES FUNCIONALES

Componente ISAS	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Clínica
Sección I: Fenomenología	13 formas	Frecuencias	Historia vital de cortes, quemaduras, golpes, pellizcos, etc., edad de inicio, dolor físico y aislamiento.
Sección II-A: Intrapersonal	5 funciones	0 a 30	Regulación afectiva, antidisociación, antisuicidio, marcar distrés y autocastigo (3 reactivos por función).
Sección II-B: Interpersonal	8 funciones	0 a 48	Búsqueda de ayuda, influencia interpersonal, límites interpersonales, pertenencia grupal, venganza, etc.
TOTAL FUNCIONAL	39 reactivos	0 a 78	Perfil jerárquico de refuerzos que sostienen operativamente la conducta autolesiva.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad: alfa de Cronbach de 0.88 para la escala intrapersonal y 0.86 para la escala interpersonal en población española (Pérez et al., 2020).
Validez Estructural	El análisis factorial confirmatorio ratifica la estructura de segundo orden compuesta por dos superfactores (Intrapersonal e Interpersonal) que explican las 13 funciones primarias.
Validez Convergente	Correlaciones significativas y positivas con la escala DERS de desregulación emocional ($r = 0.62$ con función intrapersonal) y con síntomas de Trastorno Límite de la Personalidad (BPDL $r = 0.58$).
Función Antis suicidio	La función antisuicidio del ISAS correlaciona fuertemente con antecedentes de ideación de muerte y hospitalizaciones psiquiátricas previas.
Estabilidad Temporal	Confiabilidad test-retest $r = 0.79$ a 0.84 a las cuatro semanas en muestras clínicas adolescentes y de adultos jóvenes.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN FUNCIONAL

La corrección se articula en dos niveles de análisis cualitativo y cuantitativo:

- **Sección I (Conductas):** Se contabiliza el número total de métodos empleados (versatilidad autolesiva) y la frecuencia estimada global a lo largo de la vida y en el último año.
- **Sección II (39 afirmaciones funcionales):** Cada afirmación se califica con:

0 = Nada relevante / No me aplica | 1 = Algo relevante | 2 = Muy relevante

- **Cálculo de Subescalas Funcionales:** Cada una de las 13 funciones consta de 3 reactivos específicos (puntuación de 0 a 6 puntos por función). Se identifican las funciones **primarias dominantes** (puntuaciones de 4 a 6).

6. INTERPRETACIÓN DE PERFILES FUNCIONALES (KLONSKY & GLENN, 2009)

Superfactor	Puntuación	Predominio Clínico	Dianas Terapéuticas Prioritarias
Intrapersonal	Dominante en >80%	Alivio de dolor afectivo, desahogo, cese de disociación	Entrenamiento en tolerancia al malestar, habilidades de modulación emocional y mindfulness (DBT).
Interpersonal	Secundario o mixto	Señal de socorro, solicitud de ayuda, poner límites	Entrenamiento en eficacia interpersonal, comunicación asertiva de necesidades y manejo del entorno familiar.
Antis suicidio	Reactivos 8, 21, 34	Alerta de Máxima Gravedad	Uso del dolor somático para frenar impulsos letales inmediatos. Plan de seguridad y derivación intensiva.

ÍNDICE DE GRAVEDAD POR POLIMÉTODO (VERSATILIDAD): El empleo de **≥ 3 métodos distintos de autolesión** (p. ej., cortes, quemaduras e impactos) constituye un marcador de alto riesgo psicopatológico, predictivo de refractariedad al tratamiento ambulatorio simple y comorbilidad con traumas tempranos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y ABORDAJE TERAPÉUTICO

ANÁLISIS FUNCIONAL EN CADENA (TERAPIA DIALÉCTICO-CONDUCTUAL):

- **Vulnerabilidad previa:** Identificar déficits de sueño, conflictos interpersonales o sobrecarga sensorial.
- **Eslabón disparador:** Pensamiento de rechazo o emoción intolerable (vergüenza, culpa, rabia).
- **Función operante detectada:** Si es **Regulación Afectiva** (ISAS), sustituir inmediatamente por estimulación sensorial intensa opuesta (hielo, duchas frías, ejercicio intenso: habilidades TIPP). Si es **Autocastigo**, trabajar compasión y reestructuración de la culpa.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: ADOLESCENTE CON CORTES RECURRENTES

Paciente: Chica de 17 años, estudiante de bachillerato, derivada tras detectarse múltiples cortes longitudinales en antebrazos y muslos en la clase de educación física. Refiere una historia de autolesiones de 18 meses de evolución.

Resultados ISAS:

- **Sección I:** 2 métodos activos (cortes y quemaduras superficiales con mechero). Inicio a los 15 años. Reporta no sentir dolor durante los episodios y practicarlos en absoluta soledad.
- **Sección II:** Puntuación Intrapersonal = 26/30 (Regulación afectiva = 6/6, Antisociación = 5/6, Autocastigo = 6/6); Puntuación Interpersonal = 4/48 (muy baja relevancia; no busca atención externa). Función Antisuicidio = 4/6 ("me corto para no quitarme la vida").

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno de Autolesión No Suicida y rasgos del espectro límite. Se implementa entrenamiento en habilidades DBT en formato individual y grupal multifamiliar. Se sustituyen los cortes por sujeción de cubos de hielo y técnicas de respiración diafragmática. A los 4 meses, la frecuencia de episodios se redujo a cero, manteniendo estabilidad conductual.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN DEL RIESGO DE SUICIDIO

ALERTA: TRÁNSITO A CONDUCTA SUICIDA

Aunque la AINS carece de intencionalidad letal consciente, incrementa la capacidad adquirida para el suicidio por habituación al dolor físico. Todo paciente con ISAS positivo requiere evaluación formal de riesgo con la escala C-SSRS.

ATENCIÓN MÉDICA DE LESIONES

El evaluador debe inspeccionar o asegurar la valoración médica de las heridas físicas existentes para descartar infecciones, sepsis o necesidad de sutura quirúrgica urgente.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Klonsky, E. D., & Glenn, C. R. (2009). Assessing the functions of non-suicidal self-injury: Psychometric properties of the Inventory of Statements About Self-injury (ISAS). *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 31(3), 215–225.
2. Pérez, S., García-Alandete, J., Cañabate, M., & Marco, J. H. (2020). Psychometric properties of the Inventory of Statements About Self-injury (ISAS) in Spanish clinical adolescents. *Journal of Clinical Psychology*, 76(6), 1145–1160.
3. García-Nieto, R., Carballo, J. J., Díaz de Neira, M., de León-Martínez, V., & Baca-García, E. (2013). Validación de la versión española del inventario de autolesiones físicas (ISAS). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 41(5), 295–302.
4. Nock, M. K. (2010). Self-injury. *Annual Review of Clinical Psychology*, 6, 339–363.